

Fobias específicas y fobia social

1. Introducción y relevancia clínica

Las **fobias** son trastornos caracterizados por un **miedo irracional, desproporcionado y persistente** ante un objeto, situación o escenario concreto, que lleva a **conductas de evitación o malestar intenso**.

Existen dos categorías principales:

- **Fobia específica:** miedo a un estímulo concreto (animales, alturas, sangre, vuelos, etc.).
- **Fobia social (o ansiedad social):** miedo a situaciones donde la persona puede ser evaluada o humillada ante otros.

Aunque el paciente **reconoce que su miedo es irracional**, no logra controlarlo.

El resultado es **evitación conductual**, deterioro funcional y ansiedad anticipatoria.

Las fobias tienen una **alta prevalencia**, afectando entre **7 y 10% de la población general**, con inicio temprano (infancia en fobias específicas, adolescencia en fobia social).

En Chile, son motivo frecuente de consulta en atención primaria y servicios de salud mental.

□ En el **EUNACOM**, las fobias se preguntan en:

- Diferencias clínicas entre fobia, pánico y ansiedad generalizada.
- Tratamiento de primera línea (TCC con exposición).
- Uso apropiado de fármacos en fobia social.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Las fobias se explican por la interacción de **factores biológicos, psicológicos y de aprendizaje**.

2.1. Bases neurobiológicas

- **Amígdala cerebral:** estructura central en la respuesta de miedo condicionado.
- **Hiperactividad del sistema límbico** ante estímulos fóbicos, con pobre modulación cortical.
- **Disminución del control inhibitorio** de la corteza prefrontal medial.
- **Sistema serotoninérgico y GABAérgico:** involucrados en la regulación de la ansiedad.

2.2. Teoría del aprendizaje (condicionamiento clásico)

- Una experiencia traumática o desagradable con un estímulo neutro (p. ej. perro → mordida) genera **asociación de miedo**.
- Luego, el estímulo por sí mismo evoca la respuesta fóbica (miedo condicionado).

2.3. Factores psicológicos y genéticos

- Historia familiar de ansiedad o temperamento inhibido.
 - Aprendizaje vicario (observar fobias en padres o modelos).
 - Factores cognitivos: **sobreestimación del peligro** y **subestimación de la capacidad de afrontamiento**.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Fobia específica

DSM-5: miedo o ansiedad intensa ante un objeto o situación específica, con estas características:

1. El estímulo fóbico **casi siempre provoca miedo inmediato**.
2. El paciente **reconoce el miedo como excesivo o irracional**.
3. Evita o soporta con intensa ansiedad la situación.
4. El miedo causa **malestar significativo o deterioro funcional**.

5. Duración ≥ 6 meses.

Subtipos frecuentes:

- Animal (perros, arañas, serpientes).
- Ambiental (alturas, tormentas, oscuridad).
- Sangre–inyecciones–heridas.
- Situacional (aviones, ascensores, conducir).

Ejemplo clínico EUNACOM: mujer joven con “ataques de ansiedad solo al volar”, sin crisis espontáneas → **fobia situacional**.

3.2. Fobia social (Trastorno de Ansiedad Social)

Definición: miedo persistente a actuar de manera embarazosa o ser humillado frente a otros, provocando **evitación de situaciones sociales o de desempeño**.

Criterios DSM-5:

- Miedo a una o más situaciones sociales donde puede ser evaluado (hablar en público, comer frente a otros, reuniones, exámenes).
- Temor a mostrar síntomas de ansiedad y ser juzgado.
- Las situaciones sociales casi siempre provocan ansiedad o ataques de pánico.
- Evitación o malestar intenso desproporcionado.
- Duración ≥ 6 meses, con impacto funcional.

Tipos:

- **Generalizada:** miedo en la mayoría de las interacciones sociales.
- **Específica:** miedo limitado a una actividad (p. ej., hablar en público).

Ejemplo clásico: estudiante universitario con taquicardia y bloqueo al rendir exámenes orales → **fobia social específica**.

3.3. Manifestaciones clínicas comunes

- Palpitaciones, sudoración, temblor, rubor facial.
 - Sequedad bucal, dificultad para hablar.
 - Tensión muscular, malestar gastrointestinal.
 - Evitación o ansiedad anticipatoria días antes del evento temido.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferenciación clave
Trastorno de pánico	Crisis espontáneas, sin estímulo específico.
TAG	Ansiedad difusa y constante, no situacional.
Trastorno de personalidad evitativo	Patrón crónico de timidez e inhibición social generalizada, sin crisis fóbicas.
Esquizofrenia / paranoia	Miedo basado en delirios o alucinaciones (no en evaluación social real).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico**.

No se requieren exámenes específicos, salvo para descartar comorbilidades médicas (p. ej., hipertiroidismo, consumo de estimulantes).

Herramientas útiles:

- **Escala de ansiedad social de Liebowitz (LSAS)**: mide intensidad y evitación.

- **Inventario de miedos de Marks y Mathews:** útil para fobias específicas.
-

5. Tratamiento (según Guía MINSAL / Chile 2023)

El tratamiento es principalmente **psicoterapéutico**, siendo la **terapia cognitivo-conductual (TCC)** el estándar de oro.

Los fármacos se reservan para casos moderados a graves, especialmente en **fobia social generalizada**.

5.1. Terapia cognitivo-conductual

Componentes principales:

- **Exposición gradual o sistemática:** enfrentar progresivamente el estímulo temido en condiciones controladas.
- **Desensibilización sistemática:** combinación de exposición con relajación.
- **Reestructuración cognitiva:** identificar pensamientos irracionales (“me van a humillar”) y reemplazarlos por evaluaciones realistas.
- **Entrenamiento en habilidades sociales:** en fobia social.
- **Prevención de evitación:** clave para consolidar la mejoría.

□ La TCC tiene eficacia comprobada en **70–90% de fobias específicas** y es **tratamiento de elección** en guías internacionales y MINSAL.

5.2. Farmacoterapia

Fobia específica

- **No se indica farmacoterapia de base.**
- En casos seleccionados (p. ej., vuelo, procedimientos médicos):
 - **Benzodiacepinas de acción corta** (lorazepam, alprazolam) 30–60 min antes del estímulo.

Fobia social

Primera línea: ISRS (igual que en TAG o pánico).

- **Sertralina 25–50 mg/día** → titular hasta 200 mg.
- **Paroxetina 10–20 mg/día.**
- **Escitalopram o fluoxetina:** alternativas eficaces.

Segunda línea:

- **Venlafaxina XR (IRSNa):** 75–225 mg/día.

Benzodiacepinas:

- Solo uso breve para ansiedad intensa inicial (2–4 semanas).
- Evitar en pacientes con abuso de sustancias.

Otros fármacos:

- **Betabloqueadores (propranolol 10–40 mg VO)** 1 h antes de exposición para controlar síntomas autonómicos (taquicardia, temblor), útil en **fobia escénica**.

5.3. Medidas complementarias

- Técnicas de relajación y respiración.
- Entrenamiento en mindfulness.
- Actividad física regular.
- Reducción de cafeína y estimulantes.

5.4. Duración del tratamiento

- Mantener ISRS **mínimo 12 meses** tras remisión.

- La exposición y la TCC deben prolongarse hasta que el paciente pueda **afrentar sin ansiedad significativa**.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- **Evitación social progresiva** → aislamiento.
- **Abandono laboral o escolar**.
- **Depresión secundaria**.
- **Abuso de alcohol o sedantes** como automedicación.

Pronóstico

- **Excelente en fobias específicas** con TCC (remisión completa en >90%).
 - **Bueno en fobia social** si hay adherencia y abordaje combinado.
 - **Peor pronóstico**: inicio temprano, tipo generalizado, ausencia de apoyo social.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Fobia específica**: miedo a un estímulo concreto; **fobia social**: miedo al juicio de otros.
2. **Exposición gradual** es el tratamiento más efectivo.
3. Los **ISRS** son de elección en **fobia social generalizada**.
4. **Propranolol** sirve para síntomas autonómicos en fobia de desempeño.

5. La **evitación perpetúa** la ansiedad y debe ser abordada activamente.
 6. En **fobias específicas aisladas, no se indican fármacos crónicos**.
 7. Diagnóstico es **clínico**, sin exámenes complementarios.
-



Errores comunes

- Tratar fobias específicas solo con fármacos.
 - Confundir fobia social con timidez normal.
 - No incluir **exposición conductual** en el manejo.
 - Mantener benzodiacepinas en forma prolongada.
 - Ignorar comorbilidades depresivas o abuso de alcohol.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **fobias** son miedos irracionales, específicos o sociales, que generan evitación significativa.
2. El diagnóstico es **clínico**, basado en la persistencia y desproporción del miedo.
3. La **Terapia Cognitivo-Conductual con exposición gradual** es el **tratamiento de elección**.
4. En **fobia social**, se añaden **ISRS (sertralina, paroxetina)** según severidad.
5. **Benzodiacepinas o betabloqueadores** solo en casos seleccionados y breves.
6. Las **fobias específicas tienen excelente pronóstico** con tratamiento adecuado.
7. Evitar la cronificación mediante **psicoeducación y prevención de evitación**.